



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PANDUAN
SISTEM RUJUKAN STUNTING DAN WASTING
RS PRIMA HUSADA**

Jl. Raya Surabaya - Malang No. KM 54, Sukorejo - Pasuruan

Telp. 0343 - 6745000

Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

LEMBAR PENGESAHAN
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR: 935.103/RSPHS/I-PER/DIR/XI/2025

TENTANG

PANDUAN SISTEM RUJUKAN STUNTING DAN WASTING
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

Disusun oleh:

Ketua Tim



(dr. Ratih Kusumawardani, Sp.A., M.Biomed)

Disetujui oleh:

Authorized Person



(Dr. dr. Aslichah, M.Kes., AFP)

Ditetapkan oleh:

Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo



(Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep., M.Kep)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Panduan Sistem Rujukan Stunting dan Wasting Rumah Sakit Prima Husada ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Stunting dan wasting merupakan permasalahan gizi yang memiliki dampak serius terhadap kualitas sumber daya manusia, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Penanganan yang komprehensif dan berkesinambungan membutuhkan sistem rujukan yang terstruktur, efektif, dan terintegrasi antar unit di dalam rumah sakit maupun antar fasilitas pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, keberadaan panduan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi tenaga kesehatan dalam melakukan identifikasi, penatalaksanaan, serta mekanisme rujukan pasien dengan kondisi stunting dan wasting secara tepat, cepat, dan sesuai standar pelayanan.

Panduan ini disusun dengan mengacu pada kebijakan nasional, standar pelayanan kesehatan, serta prinsip keselamatan pasien dan mutu pelayanan. Selain itu, panduan ini juga mempertimbangkan koordinasi lintas sektor dan kesinambungan pelayanan dari tingkat primer hingga rujukan lanjutan.

Kami menyadari bahwa panduan ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, masukan dan saran yang membangun sangat diharapkan guna penyempurnaan di masa mendatang. Semoga panduan ini dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan serta mendukung percepatan penurunan stunting dan wasting di Indonesia.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan panduan ini

Pasuruan, 01 Januari 2026

Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo



Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep., M.Kep

TIM PENYUSUN
PANDUAN SISTEM RUJUKAN STUNTING DAN WASTING

PENGARAH

1. Dr. dr. Aslichah, M.Kes., AFP
2. Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep., M.Kep

PENYUSUN

1. dr. Ratih Kusumawardani, Sp.A., M.Biomed
2. dr. Achmad Fauzan Ailani
3. Annisa' Dwi Khumairoh, A.Md.Gz.
4. Ayu Mayang Priningtiyas, S.Kep.Ns
5. Iin Widowati, S.Tr.Keb
6. Riska Amelia Putri, S.Tr.Gz
7. Shinta Aprilia Rizky Wulandari, S.Farm., Apt
8. Novi Dwi Hidayati, S.Tr.Kes

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
TIM PENYUSUN	iv
DAFTAR ISI	v
PERATURAN DIREKTUR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	1
1.3 Ruang Lingkup	1
1.4 Batasan Operasional	1
BAB II STANDAR KETENAGAAN	2
2.1 Struktur Organisasi Tim	2
2.2 Kualifikasi, Uraian Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang	3
BAB III TATA LAKSANA SISTEM RUJUKAN	7
3.1 Prinsip Rujukan	7
3.2 Kriteria Rujukan	7
3.3 Rujukan Masuk	7
3.4 Rujukan Internal	7
3.5 Rujukan Keluar/Eksternal	7
3.6 Pencatatan dan Pelaporan	8
3.7 Monitoring dan Dokumentasi	8
BAB IV PENUTUP	9



PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR: 935.103/RSPHS/I-PER/DIR/XI/2025

TENTANG

PANDUAN SISTEM RUJUKAN STUNTING DAN WASTING

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA,

- Menimbang : a. Bahwa stunting dan wasting merupakan masalah gizi yang berdampak pada morbiditas, mortalitas, dan kualitas hidup pasien, sehingga memerlukan penanganan yang komprehensif dan berkesinambungan;
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan serta mendukung Program Nasional Percepatan Penurunan Stunting, diperlukan sistem rujukan yang efektif, efisien dan terintegrasi;
- c. Bahwa untuk menjamin kesinambungan pelayanan pasien stunting dan wasting, perlu disusun panduan sistem rujukan di rumah sakit;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan Peraturan Direktur tentang Panduan Sistem Rujukan Stunting dan Wasting Rumah Sakit Prima Husada.
- Mengingat : 1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. PP No. 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Perpres No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
4. PMK No. 78 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Gizi RS;
5. PMK No. 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak;
6. KMK Nomor HK.01.07/MENKES/1928/2022 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Stunting;
7. Kepdirjen Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
8. Kepdirjen Nomor HK.02.02/D/43961/2024 tentang Pedoman Survei Akreditasi Rumah Sakit;
9. Kepdirjen Nomor HK.02.02/D/47104/2024 tentang Instrumen Survei Akreditasi Rumah Sakit;
10. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor: 953.4/RSPHS/I-KEP/DIR/XI/2025 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo;
11. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor: 1110/DPM/I-KEP/DIR/XI/2025 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PANDUAN SISTEM RUJUKAN STUNTING DAN WASTING RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:



- (1) Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada balita akibat kekurangan gizi dalam waktu lama, yang ditandai dengan PB/U atau TB/U < -2 SD;
- (2) Wasting adalah kondisi kurus yang disebabkan oleh kekurangan gizi akut dan/atau penyakit, yang ditandai dengan BB/PB atau BB/TB < -2 SD. Namun, jika nilainya < -3 SD dan/atau LiLA $< 11,5$ cm pada balita usia 6-59 bulan yang disertai edema bilateral dikategorikan sebagai Severe Wasting (Gizi Buruk);
- (3) Sistem rujukan adalah penyelenggaraan pelimpahan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik, baik vertikal atau horizontal, antar fasilitas kesehatan berdasarkan kebutuhan medis, kemampuan pelayanan, serta kewenangan, guna menjamin pasien memperoleh pelayanan yang tepat, bermutu, dan berkesinambungan.

BAB II PENGORGANISASIAN

Pasal 2

- (1) Rumah sakit membentuk tim pelayanan stunting dan wasting melalui SK Direktur;
- (2) Tim yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tenaga kesehatan multidisiplin ilmu yang memiliki kompetensi sesuai standar profesi;
- (3) Tim pelayanan stunting dan wasting diketuai oleh staf medis atau dokter spesialis anak;
- (4) Yang termasuk dalam keanggotaan tim stunting dan wasting sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Staf medis
 - b. Staf keperawatan
 - c. Staf kebidanan
 - d. Staf instalasi gizi
 - e. Staf instalasi farmasi
 - f. Staf humas

BAB III

Pasal 3

Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam panduan ini meliputi:

- (1) Skrining, deteksi dini dan penegakan diagnosis;
- (2) Tata laksana awal sesuai standar pelayanan;
- (3) Prosedur rujuk internal dan eksternal;
- (4) Koordinasi lintas fasilitas kesehatan (jejaring rujukan);
- (5) Pencatatan dan pelaporan.
- (6) Monitoring dan evaluasi.

Pasal 4

Kebijakan Sistem Rujukan

- (1) Rumah sakit melaksanakan pelayanan sebagai pusat rujukan kasus stunting dan wasting dengan atau tanpa komplikasi medis;
- (2) Setiap pasien stunting dan wasting harus mendapatkan pelayanan sesuai standar klinis dan kebutuhan medis;
- (3) Rumah sakit wajib melaksanakan sistem rujukan secara berjenjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (4) Rujukan dilakukan berdasarkan indikasi medis, ketersediaan sumber daya, dan kompetensi fasilitas pelayanan kesehatan;
- (5) Sistem rujukan dilaksanakan secara terintegrasi dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama dan lanjutan.



BAB IV

Pasal 5

Pelaksanaan Rujukan

- (1) Rujukan masuk dilakukan melalui sistem rujukan yang berlaku dengan dilengkapi dokumen medis yang lengkap;
- (2) Rujukan internal dilakukan antar unit dalam rumah sakit lintas sektor dengan pelayanan terpadu;
- (3) Rujukan keluar/eksternal dilakukan apabila pasien membutuhkan pelayanan lanjutan yang tidak tersedia di rumah sakit;
- (4) Setiap rujukan harus disertai komunikasi antar tenaga kesehatan untuk menjamin kesinambungan pelayanan.

Pasal 6

Kriteria Rujukan

- (1) Kriteria rujukan meliputi kondisi klinis, komplikasi, dan kebutuhan penanganan spesialistik;
- (2) Rujukan kasus gizi buruk dengan komplikasi harus dilakukan segera ke fasilitas yang lebih mampu.

Pasal 7

Pencatatan dan Pelaporan

- (1) Setiap proses rujukan wajib didokumentasikan dalam rekam medis;
- (2) Data rujukan digunakan untuk evaluasi mutu pelayanan dan pelaporan program pelayanan stunting dan wasting.

Pasal 8

Monitoring dan Evaluasi

- (1) Rumah sakit melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan sistem rujukan;
- (2) Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan mutu pelayanan.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan

Pada tanggal 01 Januari 2026

Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo,



Ns. Heni Indra Wulansari, S. Kep., M. Kep

PANDUAN PELAYANAN STUNTING DAN WASTING

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Stunting dan wasting merupakan masalah gizi utama yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia serta meningkatkan risiko morbiditas dan mortalitas, khususnya pada anak. Wasting berhubungan dengan kekurangan gizi akut yang meningkatkan risiko kematian hingga beberapa kali lipat, sedangkan stunting merupakan kondisi kronis yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan jangka panjang.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai kebijakan dalam upaya percepatan penurunan stunting, salah satunya melalui Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK) Tata Laksana Stunting yang menjadi acuan standar pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan. Dalam konteks rumah sakit, berdasarkan standar akreditasi terbaru, rumah sakit wajib menyelenggarakan program penurunan prevalensi stunting dan wasting, termasuk penguatan jejaring rujukan dan kesinambungan pelayanan.

Rumah sakit tidak hanya berperan sebagai fasilitas pelayanan rujukan, tetapi juga sebagai pusat koordinasi klinis, edukasi, serta penguatan jejaring pelayanan kesehatan dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan rumah sakit lain. Oleh karena itu, diperlukan panduan sistem rujukan yang terstandar, terintegrasi, dan berkelanjutan.

1.2 Tujuan

1. Tujuan Umum
Menjadi acuan dalam pelaksanaan sistem rujukan stunting dan wasting di rumah sakit guna menjamin pelayanan yang komprehensif, berkesinambungan, dan bermutu..
- 2 Tujuan Khusus
 - a. Menjamin proses rujukan berjalan efektif dan efisien
 - b. Meningkatkan mutu dan keselamatan pasien
 - c. Memperkuat koordinasi antar fasilitas pelayanan kesehatan
 - d. Mendukung program nasional percepatan penurunan stunting
 - e. Menjadi dasar dalam pemenuhan standar akreditasi rumah sakit

1.3 Ruang Lingkup

1. Skrining, deteksi dini dan penegakan diagnosis
2. Tata laksana awal sesuai standar pelayanan
3. Prosedur rujuk internal dan eksternal
4. Koordinasi lintas fasilitas kesehatan (jejaring rujukan)
5. Pencatatan dan pelaporan
6. Monitoring dan evaluasi

1.4 Batasan Operasional

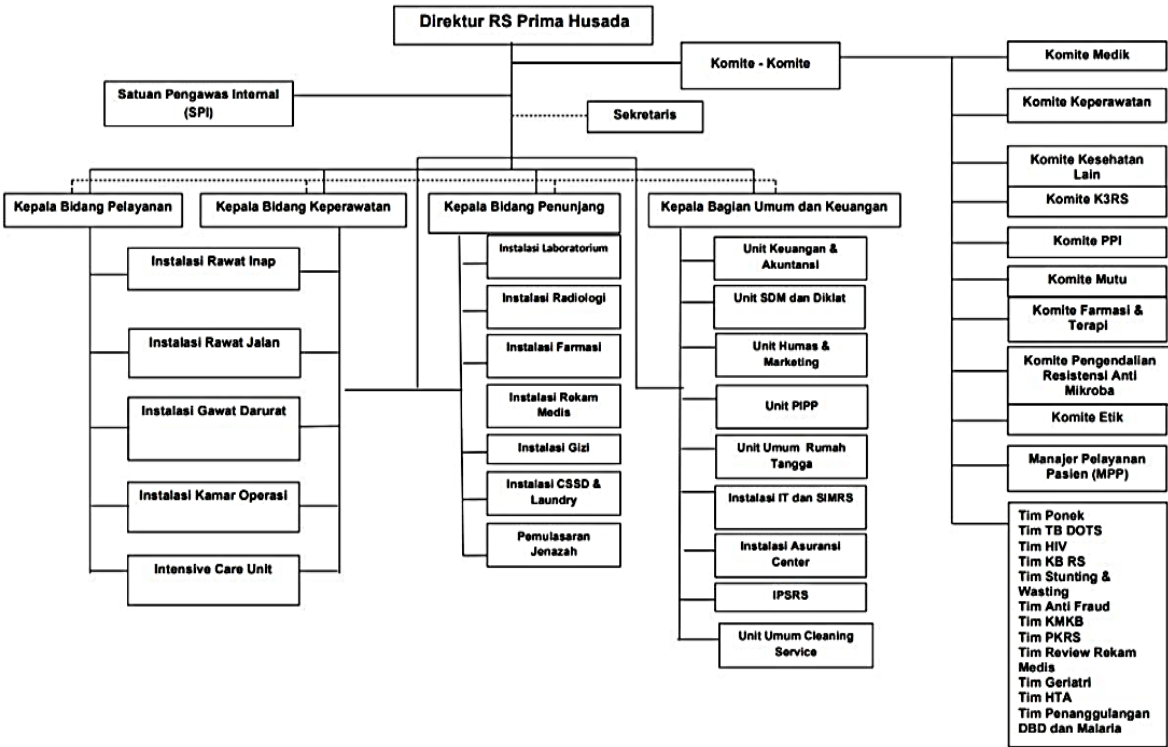
1. Rujukan internal dilakukan bila membutuhkan pelayanan spesialis/penunjang.
2. Rujukan eksternal dilakukan bila fasilitas atau kompetensi tidak tersedia.
3. Rujuk balik dilakukan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk tindak lanjut.

BAB II
PENGORGANISASIAN

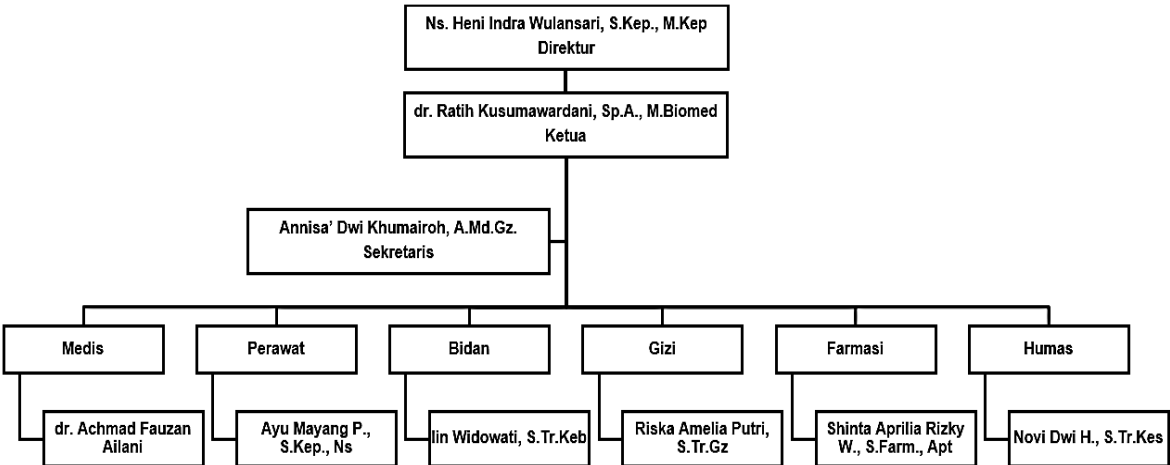
2.1 Struktur Organisasi Tim

Susunan dan struktur keanggotaan tim pelayanan stunting dan wasting di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo antara lain:

- Ketua : dr. Ratih Kusumawardani, Sp. A., M. Biomed
- Sekretaris : Annisa' Dwi Khumairoh, A.Md.Gz
- Anggota :
- Staf Medis : dr. Achmad Fauzan Ailani
- Staf Keperawatan : Ayu Mayang Priningtiyas, S.Kep., Ns
- Staf Kebidanan : Iin Widowati, S.Tr.Keb
- Staf Gizi : Riska Amelia Putri, S.Tr.Gz
- Staf Farmasi : Shinta Aprilia Rizky Wulandari, S.Farm., Apt
- Staf Humas : Novi Dwi Hidayati, S.Tr.Kes



Gambar 2.1 SOTK Rumah Sakit



Gambar 2.2 SOTK Tim Pelayanan Stunting dan Wasting

2.2 Kualifikasi, Uraian Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang

1. Ketua Tim

a. Kualifikasi

- 1) Staf medis, diutamakan DSA, memiliki STR dan SIP yang masih berlaku
- 2) Memiliki kompetensi dalam penanganan stunting dan wasting
- 3) Memiliki pengalaman pelayanan kesehatan anak di RS (min 3 tahun)
- 4) Memiliki kemampuan kepemimpinan, koordinasi, dan manajemen tim
- 5) Memahami pedoman nasional penanganan stunting dan wasting serta standar pelayanan rumah sakit.

b. Uraian Tugas

- 1) Memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan tim
- 2) Menyusun kebijakan teknis serta strategi pelaksanaan pelayanan
- 3) Mengarahkan skrining, diagnosis, tata laksana, dan pemantauan pasien
- 4) Mengkoordinasikan kerja sama antar profesi dalam tim pelayanan
- 5) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program
- 6) Melaporkan pelaksanaan kegiatan tim kepada pimpinan rumah sakit
- 7) Mengembangkan peningkatan mutu pelayanan melalui pelatihan, audit klinis, dan evaluasi pelayanan.

c. Tanggung Jawab

- 1) Bertanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan stunting dan wasting yang efektif, terpadu, dan sesuai standar pelayanan
- 2) Menjamin koordinasi antar tenaga kesehatan dalam tim berjalan baik
- 3) Menjamin pelayanan diberikan sesuai standar profesi, standar prosedur operasional, dan keselamatan pasien
- 4) Bertanggung jawab atas pencapaian mutu pelayanan stunting dan wasting
- 5) Bertanggung jawab terhadap laporan, data, dan semua informasi yang dikeluarkan oleh tim sebagai hasil pelaksanaan program kepada pimpinan rumah sakit dan ataupun dari dinas terkait.

d. Wewenang

- 1) Menunjuk dan menetapkan sekretaris dan anggota tim
- 2) Menetapkan rencana kerja dan kegiatan tim
- 3) Mengarahkan dan mengoordinasikan seluruh anggota tim dalam pelayanan
- 4) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan tim
- 5) Memberikan rekomendasi kepada pimpinan rumah sakit terkait pengembangan pelayanan stunting dan wasting
- 6) Memutuskan kebijakan yang berlaku untuk program stunting dan wasting sesuai dengan perundang-undangan.

2. Sekretaris Tim

a. Kualifikasi

- 1) Tenaga kesehatan/tenaga administrasi kesehatan yang ditunjuk oleh ketua
- 2) Memiliki pendidikan minimal D-III
- 3) Memiliki kemampuan administrasi, koordinasi, dan pengelolaan dokumen
- 4) Memahami sistem pelaporan dan pencatatan pelayanan kesehatan
- 5) Mampu bekerjasama dengan seluruh anggota tim.

b. Uraian Tugas

- 1) Mengelola administrasi kegiatan tim
- 2) Menyusun rencana kegiatan dan jadwal pertemuan tim
- 3) Menyiapkan dokumen, laporan, dan notulen rapat tim
- 4) Mengkoordinasikan penyusunan laporan kegiatan pelayanan
- 5) Mengelola data dan dokumentasi kegiatan tim
- 6) Mendukung kelancaran koordinasi antar anggota tim.

c. Tanggung Jawab

- 1) Bertanggung jawab terhadap kelengkapan administrasi dan dokumentasi

-
- 2) Menjamin ketepatan dan keteraturan pencatatan serta pelaporan kegiatan
 - 3) Mendukung pelaksanaan program tim agar efektif dan terkoordinasi
 - 4) Bertanggung jawab pada ketua tim.
- d. Wewenang
- 1) Mengelola dan menyimpan dokumen kegiatan tim
 - 2) Menghimpun data dan laporan dari anggota tim
 - 3) Menyampaikan informasi kegiatan tim kepada seluruh anggota tim
 - 4) Melakukan komunikasi internal dan eksternal kepada unit kerja lingkungan rumah sakit dan pihak luar melalui surat tertulis, email, ataupun telepon
 - 5) Menyusun laporan kegiatan kepada ketua tim dan pimpinan rumah sakit.

3. Anggota Tim

a. Staf Medis

- 1) Kualifikasi
 - a) Dokter umum yang memiliki STR dan SIP yang masih berlaku
 - b) Memiliki kompetensi dalam pelayanan kegawat daruratan dan penatalaksanaan awal masalah kesehatan anak.
 - c) Memahami skrining, deteksi dini, dan tata laksana awal kasus stunting dan wasting pada bayi dan anak
 - d) Mampu bekerja sama dalam tim multidisiplin dalam pelayanan
- 2) Uraian Tugas
 - a) Melakukan skrining awal pasien dengan dugaan stunting dan wasting melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pengukuran antropometri.
 - b) Menegakkan diagnosis awal dan memberi tata laksana sesuai kondisi
 - c) Menentukan pemeriksaan penunjang yang diperlukan
 - d) Melakukan stabilisasi pasien apabila terdapat komplikasi
 - e) Berkoordinasi dengan DSA dan tim pelayanan stunting dan wasting
 - f) Melakukan rujukan internal atau eksternal bila diperlukan
 - g) Mendokumentasikan pelayanan dalam rekam medis.
- 3) Tanggung Jawab
 - a) Bertanggung jawab atas ketepatan diagnosis awal dan penatalaksanaan medis pasien
 - b) Menjamin pelayanan medis diberikan sesuai standar profesi dan prosedur yang berlaku
 - c) Menjamin keselamatan pasien selama pelayanan di IGD.
- 4) Wewenang
 - a) Melakukan pemeriksaan dan penilaian klinis pasien
 - b) Menetapkan diagnosis awal dan tindakan medis yang diperlukan
 - c) Meresepkan obat serta meminta pemeriksaan penunjang
 - d) Melakukan konsultasi atau rujukan pada DSA atau unit terkait.

b. Staf Keperawatan

- 1) Kualifikasi
 - a) Pendidikan minimal Diploma III Keperawatan atau Profesi Ners
 - b) Memiliki STR dan SIP Perawat yang masih berlaku
 - c) Memiliki kompetensi dalam asuhan keperawatan anak dan pemantauan status gizi
- 2) Uraian Tugas
 - a) Melakukan pengkajian keperawatan pada pasien stunting dan wasting
 - b) Melakukan pengukuran tanda vital dan antropometri pasien
 - c) Memberikan asuhan keperawatan sesuai rencana terapi medis
 - d) Membantu pemantauan pemberian nutrisi dan terapi
 - e) Memberikan edukasi kesehatan kepada pasien dan keluarga.
- 3) Tanggung Jawab
 - a) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan asuhan keperawatan

-
- b) Memastikan keselamatan pasien selama perawatan.
 - 4) Wewenang
 - a) Melaksanakan tindakan keperawatan sesuai kompetensi
 - b) Melakukan pemantauan kondisi dan melaporkan pada dokter.
 - c. Staf Kebidanan
 - 1) Kualifikasi
 - a) Pendidikan minimal Diploma III Kebidanan atau Profesi Bidan
 - b) Memiliki STR dan SIPB (Surat Izin Praktik Bidan) yang masih berlaku
 - c) Memiliki kompetensi dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak serta pemantauan pertumbuhan balita.
 - 2) Uraian Tugas
 - a) Melakukan skrining awal risiko stunting dan wasting pada bayi
 - b) Melakukan pengukuran antropometri (BB, PB/TB, lingkaran kepala)
 - c) Memberikan edukasi pada ibu mengenai ASI, MP-ASI, pola asuh gizi
 - d) Mendukung pemantauan tumbuh kembang anak.
 - e) Berkoordinasi dengan dokter dan tenaga gizi dalam pelayanan pasien
 - 3) Tanggung Jawab
 - a) Menjamin ketepatan pengukuran pertumbuhan bayi dan balita
 - b) Melaksanakan pelayanan kebidanan sesuai standar profesi dan SPO.
 - 4) Wewenang
 - a) Melakukan pelayanan kebidanan sesuai kompetensi
 - b) Melakukan deteksi dini masalah tumbuh kembang anak
 - c) Memberikan konseling kesehatan ibu dan anak.
 - d. Staf Gizi
 - 1) Kualifikasi
 - a) Pendidikan minimal Diploma III atau Sarjana Gizi/Nutrisi
 - b) Memiliki STR Tenaga Gizi dan SIP yang masih berlaku
 - c) Memiliki kompetensi dalam asuhan gizi klinik pada anak.
 - 2) Uraian Tugas
 - a) Melakukan pengkajian status gizi pasien
 - b) Menetapkan diagnosis gizi
 - c) Menyusun intervensi gizi dan rencana diet pasien
 - d) Memberikan konseling gizi kepada pasien dan keluarga
 - e) Memantau dan mengevaluasi intervensi gizi yang diberikan.
 - 3) Tanggung Jawab
 - a) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan asuhan gizi pasien
 - b) Menjamin kesesuaian diet dengan kondisi klinis pasien,
 - 4) Wewenang
 - a) Menentukan rencana diet pasien
 - b) Memberikan edukasi dan konseling gizi.
 - e. Staf Farmasi
 - 1) Kualifikasi
 - a) Pendidikan minimal Diploma III Farmasi atau Profesi Apoteker
 - b) Memiliki STR Tenaga Kefarmasian dan SIPA/SIK yang masih berlaku
 - c) Memahami pelayanan farmasi klinik
 - 2) Uraian Tugas
 - a) Menyediakan obat sesuai resep dokter
 - b) Melakukan verifikasi resep dan memastikan ketepatan obat
 - c) Memberikan informasi obat kepada pasien dan tenaga kesehatan
 - d) Memantau penggunaan obat pada pasien.
 - 3) Tanggung Jawab
 - a) Menjamin ketersediaan dan keamanan obat
 - b) Menjamin penggunaan obat yang rasional

-
- 4) Wewenang
 - a) Melakukan pelayanan kefarmasian sesuai standar
 - b) Memberikan informasi obat kepada pasien dan tenaga kesehatan
 - f. Staf Humas
 - 1) Kualifikasi
 - a) Pendidikan minimal Sarjana Kesehatan Masyarakat, Komunikasi, atau bidang terkait
 - b) Memiliki kompetensi dalam promosi kesehatan dan komunikasi publik
 - 2) Uraian Tugas
 - a) Melaksanakan kegiatan edukasi dan promosi kesehatan terkait stunting dan wasting
 - b) Menyusun media informasi, edukasi, dan komunikasi
 - c) Mendukung kegiatan penyuluhan dan kampanye kesehatan
 - d) Mengelola informasi dan publikasi program stunting dan wasting.
 - 3) Tanggung Jawab
 - a) Menjamin penyampaian informasi kesehatan yang benar dan mudah dipahami masyarakat
 - b) Mendukung peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan stunting dan wasting.
 - 4) Wewenang
 - a) Mengembangkan media komunikasi kesehatan
 - b) Melaksanakan kegiatan promosi kesehatan di lingkungan rumah sakit dan masyarakat.

BAB III

TATA LAKSANA SISTEM RUJUKAN

3.1 Prinsip Rujukan

1. Berjenjang sesuai sistem pelayanan
2. Berdasarkan indikasi medis
3. Mengutamakan keselamatan pasien
4. Terintegrasi antar fasilitas

3.2 Kriteria Rujukan

1. Stunting
 - a. Gangguan pertumbuhan dengan komplikasi
 - b. Penyakit penyerta (infeksi kronis, kelainan metabolik)
2. Wasting
 - a. Gizi buruk dengan komplikasi
 - b. Edema, anoreksia, infeksi berat
 - c. Tidak respon terhadap terapi awal

3.3 Rujukan Masuk

1. Pasien diterima dari Puskesmas/FKTP, rumah sakit lain ataupun rujukan mandiri datang membawa surat rujukan dan resume medis yang terdapat data status gizi dan riwayat pengobatan. (jika ada).
2. Petugas melakukan skrining dan pengukuran antropometri sesuai standar pelayanan.
3. Pasien dengan indikasi stunting dan/atau wasting dikonsulkan ke DSA.
4. DSA melakukan asesmen komprehensif dan penegakan diagnosis serta menetapkan sistem rujukan internal ataupun eksternal sesuai dengan kondisi pasien.

3.4 Rujukan Internal

1. Pasien datang membawa buku KIA dan surat rujukan dari FKTP yang disertai resume medis (jika ada).
2. Petugas (dokter umum/bidan/perawat) melakukan skrining dan pengukuran antropometri sesuai standar pelayanan.
3. Pasien dengan indikasi stunting dan/atau wasting dikonsulkan kepada Dokter Spesialis Anak (DSA).
4. Dokter Spesialis Anak (DSA) ditetapkan sebagai DPJP dan melakukan asesmen komprehensif serta penegakkan diagnosis.
5. DPJP menetapkan kebutuhan rujukan internal ke unit terkait (gizi, rawat inap, penunjang dan/atau tumbuh kembang) sesuai indikasi klinis.
6. Pelaksanaan rujukan internal dilakukan sesuai instruksi DPJP dan dikoordinasikan secara multidisiplin.
7. DPJP melakukan evaluasi dan pemantauan berkala terhadap perkembangan pasien.
8. Seluruh pelayanan, hasil pemeriksaan, dan tindakan dicatat dalam rekam medis secara lengkap.
9. Pasien yang membaik dilakukan kontrol rawat jalan dan/atau rujuk balik ke FKTP.
10. DPJP bersama tim memberikan edukasi kepada keluarga serta menetapkan rencana tindak lanjut.

3.5 Rujukan Keluar/Eksternal

1. DPJP melakukan asesmen dan menetapkan rujukan eksternal/rujuk balik sesuai kondisi pasien.
2. DPJP menjelaskan rencana rujukan kepada keluarga dan memperoleh persetujuan.
3. Petugas menyiapkan dokumen meliputi surat rujukan/rujuk balik, resume medis, dan hasil pemeriksaan penunjang.

-
4. Petugas melakukan koordinasi dengan faskes tujuan untuk memastikan kesiapan penerimaan pasien.
 5. Pasien distabilisasi sesuai kondisi medis sebelum dirujuk.
 6. Rukukan ke FKRTL
Dilakukan apabila pasien memerlukan pelayanan yang tidak tersedia di RS Prima Husada Sukorejo. DPJP akan membuat surat rujukan ke rumah sakit yang lebih mampu dan melakukan pengisian sirsute. Pasien dirujuk dengan transportasi sesuai standar dan didampingi oleh nakes serta dilakukan serah terima pasien beserta dokumen rujukan di faskes tujuan.
 7. Rujukan balik ke FKTP
Dilakukan apabila kondisi pasien stabil untuk dilakukan pemantauan lanjutan (status gizi, terapi nutrisi, dan tumbuh kembang).
 8. Seluruh proses rujukan/rujuk balik didokumentasikan secara lengkap dalam rekam medis
 9. Rumah sakit melakukan pemantauan dan menerima umpan balik rujukan untuk menjamin kesinambungan pelayanan.

3.6 Pencatatan dan Pelaporan

Semua proses rujukan (baik internal maupun eksternal) dicatat dalam rekam medis yang mana datanya akan digunakan untuk evaluasi mutu pelayanan, pelaporan program nasional stunting dan wasting, serta surveilans gizi.

3.7 Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dilakukan secara berkala terhadap jumlah kasus rujukan, keberhasilan terapi, dan kepatuhan terhadap SOP, sedangkan evaluasi dilakukan dalam bentuk audit klinis, evaluasi program, serta upaya perbaikan berkelanjutan.

BAB IV PENUTUP

Panduan ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan sistem rujukan stunting dan wasting di rumah sakit. Dengan adanya panduan ini, diharapkan pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan stunting dan wasting menjadi lebih terstandar, terintegrasi, dan mampu mendukung program nasional pemerintah serta pemenuhan standar akreditasi rumah sakit. Panduan ini senantiasa akan disesuaikan dengan perkembangan ilmu dan teknologi serta kebijakan dan peraturan program pelayanan.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 01 Januari 2026
Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo,



Ns. Heni Indra Wulansari, S. Kep., M. Kep